

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Andrés Felipe Romero Castaño

DOCUMENTO

CC 79555123

FECHA NACIMIENTO

30/05/1993

EDAD

33 años, 0 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Profesional (Derecho)

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

11/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001241

PROTOCOLO APLICADO

WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-ACV

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Andrés Felipe Romero Castaño	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 79555123	Ocupación:	Abogado (licencia médica)
Fecha de nacimiento:	30/05/1993	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	33 años, 0 meses	Acompañante:	Carolina Mejía de Romero
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo tratante
Escolaridad:	Profesional (Derecho)	EPS / Asegurador:	Sanitas EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Control post-ACV isquémico de ACM izquierda (hace 8 meses). Hemiparesia derecha resuelta, persiste leve déficit atencional y anomia. Evaluar capacidad para reincorporación laboral.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-ACV

Prueba	Dominio	Dur.
VOCABULARIO	Comprensión Verbal	—
SEMEJANZAS	Comprensión Verbal	—
ARITMETICA	Comprensión Verbal	—
DIGITOS	Atención	—
INFORMACIÓN	Comprensión Verbal	—
COMRENSIÓN	Comprensión Verbal	—
LETRAS Y NÚMEROS	Memoria de Trabajo	—
FIG. INCOMPLETAS	Organización Perceptual	—
CLAVE DE NÚMEROS	Velocidad de Proceso	—
CONSTRUCCIÓN CUBOS	Organización Perceptual	—
MATRICES	Organización Perceptual	—
HISTORIETAS	Organización Perceptual	—
ROMPECABEZAS	Organización Perceptual	—
CI COMPRENSIÓN VERBAL	Índice CI	—
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTIVA	Índice CI	—
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO	Índice CI	—
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO	Índice CI	—
CI ESCALA TOTAL	Inteligencia General	—
Inventario de Beck BDI-II	Socioemocional - Depresión	—

ANTECEDENTES

Patológicos/ Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida y selectiva descendidas. Fatiga atencional a los 30 min. Mejora con pausas estructuradas.

Memoria

Anomia leve. Dificultad en evocación categorial. Reconocimiento preservado (perfil subcortical).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Funciones ejecutivas

Planificación descendida. Dificultad en tareas que requieren secuenciación. Flexibilidad cognitiva preservada.

Emociones y comportamiento

Síntomas depresivos subclínicos. Frustración por limitaciones residuales. Ajuste emocional en proceso.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: 169.3 - Secuelas de ACV (recuperación)

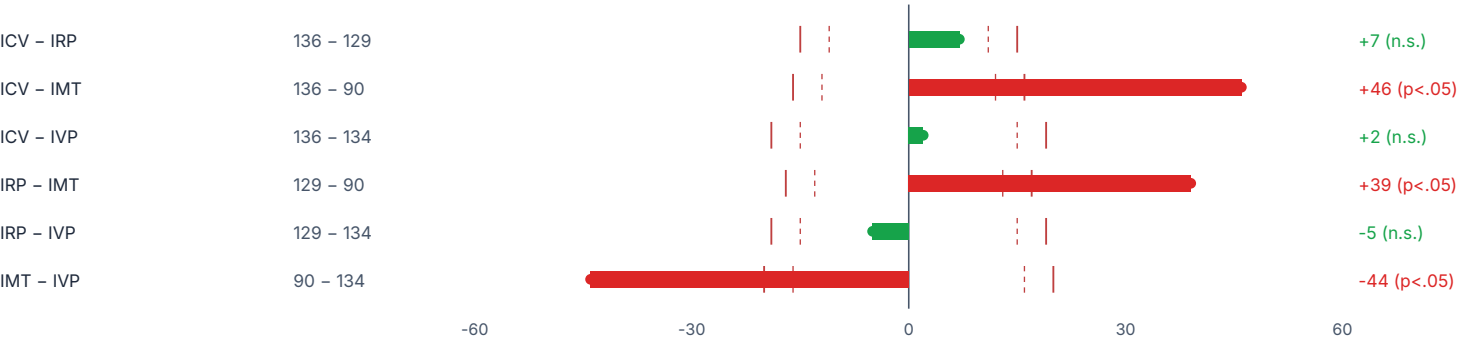
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

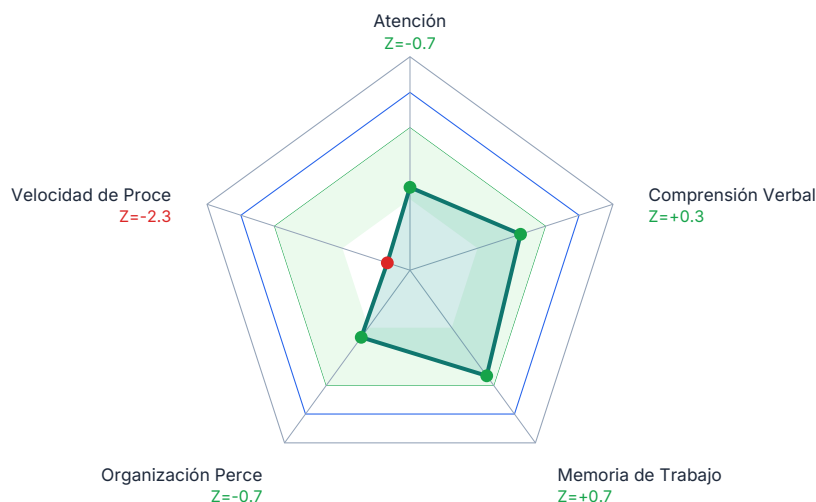
CI COMPRENSIÓN V	CI DEL INDICE OR	CI INDICE MEMORI	CI INDICE VELOCI	CI ESCALA TOTAL	Inventario de Be
136	129	90	134	88	14
Superior	Superior	Promedio	Superior	Promedio	Leve

Discrepancias entre índices

Diferencia = valor del primer índice - segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p < .15$... y $p < .05$).

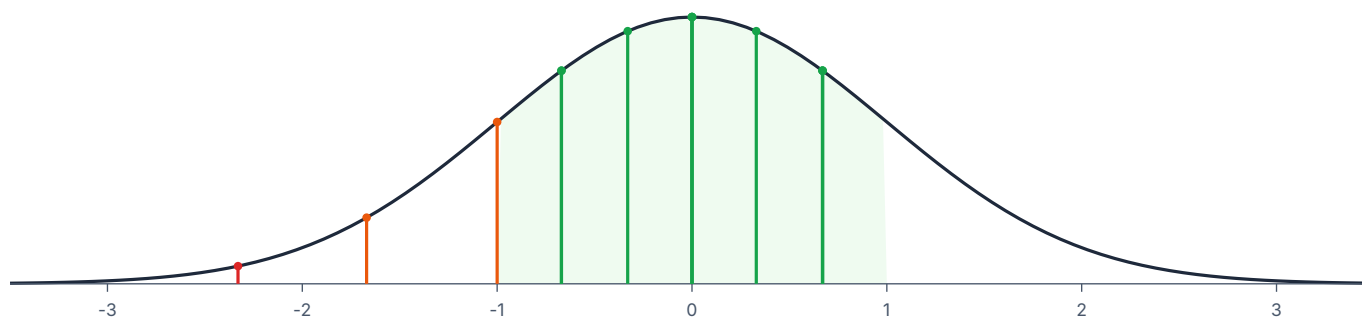


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 13 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
VOCABULARIO							-0.33
SEMEJANZAS							+0.00
ARITMETICA							+0.67
DIGITOS							-0.67
INFORMACIÓN							+0.67
COMRENSIÓN							+0.33
LETRAS Y NÚMEROS							+0.67
FIG. INCOMPLETAS							-1.67
CLAVE DE NÚMEROS							-2.33
CONSTRUCCIÓN CUBOS							-0.67
MATRICES							+0.00
HISTORIETAS							+0.00
ROMPECABEZAS							-1.00
CI COMPRENSIÓN VERBAL							+2.40
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEP							+1.93
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO							-0.67
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO							+2.27
CI ESCALA TOTAL							-0.80
Inventario de Beck BDI-II							-5.73

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
VOCABULARIO	42	9	-0.33	Promedio
SEMEJANZAS	20	10	+0.00	Promedio
ARITMETICA	16	12	+0.67	Promedio
DIGITOS	14	8	-0.67	Promedio
INFORMACIÓN	22	12	+0.67	Promedio
COMRENSIÓN	22	11	+0.33	Promedio
LETRAS Y NÚMEROS	12	12	+0.67	Promedio
FIG. INCOMPLETAS	15	5	-1.67	Límitrofe
CLAVE DE NÚMEROS	42	3	-2.33	Bajo
CONSTRUCCIÓN CUBOS	38	8	-0.67	Promedio
MATRICES	20	10	+0.00	Promedio
HISTORIETAS	16	10	+0.00	Promedio
ROMPECABEZAS	25	7	-1.00	Promedio
CI COMPRENSIÓN VERBAL	50	136	+2.40	Superior
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTI	45	129	+1.93	Superior
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO	26	90	-0.67	Promedio
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO	32	134	+2.27	Superior
CI ESCALA TOTAL	95	88	-0.80	Promedio
Inventario de Beck BDI-II	14	14	-5.73	Leve

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Andrés obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 88, ubicándose en la categoría promedio bajo (percentil aproximado 21). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IMT (90) y el más alto a ICV (136), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, Z=-2.3).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran CLAVE DE NÚMEROS (Z=-2.33, bajo); FIG. INCOMPLETAS (Z=-1.67, límiterofe); ROMPECABEZAS (Z=-1.00, promedio). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- CLAVE DE NÚMEROS — bajo (Z=-2.33)
- FIG. INCOMPLETAS — límiterofe (Z=-1.67)
- ROMPECABEZAS — promedio (Z=-1.00)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Andrés. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En AdSemWais, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En AdWAISA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En AdSDWais, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdSemWais, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdDDir, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISI, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdSDWais, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: I69

Impresión diagnóstica: I69.3 - Secuelas de ACV (recuperación)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.